Habilidades Cirúrgicas

Monitoria de TOCE

Revisão Flash · Sessão 01

Hemorragia Digestiva e Acessos Venosos

O essencial para a prova em uma página

Técnica Operatória e Cirurgia Experimental
UniBH Vespasiano

8º período · 2026.2

Elaborado por João Batista Fernandes Júnior · *Monitor de TOCE*

Material de apoio da monitoria. Não substitui as aulas, os slides nem as referências indicadas pela disciplina.

Hemorragia digestiva e acessos

Leitura de 5 minutos

Em uma frase

Reanime com periféricos calibrosos e transfusão restritiva; na alta, endoscopia (12 h se varicosa, 24 h se não); na baixa grave, angiotomografia; e saiba fazer o central guiado por ultrassom e a intraóssea.

1. **Transfusão:** hemoglobina abaixo de 7 (8 se cardiopata); no choque, pela clínica.
2. **Glasgow-Blatchford 0–1:** endoscopia ambulatorial.
3. **Forrest Ia, Ib, IIa:** hemostasia (adrenalina nunca sozinha); IBP dose alta 72 h.
4. **Varizes:** vasoativo + antibiótico já; ligadura em até 12 h.
5. **Balão** é ponte; **TIPS precoce** no alto risco.
6. **Baixa grave:** angiotomografia e embolização; Oakland ≤ 8 pode ter alta, se parou e tem seguimento.
7. **Central:** ultrassom, barreira máxima, fio na veia antes de dilatar.
8. **Intraóssea:** tíbia anteromedial; agulha firme e infusão sem inchaço.

Tempo da endoscopia

Situação	Prazo
Não varicosa	Até 24 h
Varicosa	Até 12 h
Blatchford 0–1	Ambulatorial

Pegadinha

Hematoquezia com choque pode ser hemorragia alta. Ácido tranexâmico não ajuda. Cateter central não é o melhor para correr volume.

Checklist antes da prova

- ☐ Sei reanimar e quando transfundir
- ☐ Sei Blatchford, Forrest e Rockall
- ☐ Sei o pacote da hemorragia varicosa
- ☐ Sei investigar a hemorragia baixa
- ☐ Sei a técnica de Seldinger e suas complicações
- ☐ Sei a punção intraóssea
- ☐ Sei por que o periférico corre mais